

2026 年度 診療報酬改定

管理者・指導医のための完全ガイド

賃上げ・DX・かかりつけ・急性期再編
— 4つの柱を読み解く

+3.09%

本体改定率

30年ぶりの大幅引き上げ

本日の学習目標

分析できる

改定の構造的背景と 4 つの柱の相互関係を説明できる

評価できる

自院への影響を定量的に判断できる

創造できる

施設基準取得・維持の戦略ロードマップを立案できる

改定の歴史的 위치づけ

30 年ぶりの大幅プラス改定

2024 年

+0.88%

本体 +0.46%

2026 年

+3.09%

30 年ぶり

1994 年

+3.4%

過去最大

なぜ今、30 年ぶりの引き上げが必要になったのか？

改定率の内訳

賃上げ対応

+1.70%

約 7,700 億円（55%）

物価高騰対応

+0.76%

約 3,400 億円（25%）

食費・光熱水費

+0.09%

約 400 億円（3%）

経営難緊急

+0.44%

約 2,000 億円（14%）

改定の半分以上（55%）が「賃上げ」— これは政策的メッセージ

改定の 4 本柱

1

賃上げ・物価対応

ベースアップ評価料拡充
物価対応料新設

2

医療 DX 推進

旧加算廃止→
電子的診療情報連携に統合

3

かかりつけ医
機能強化

地域包括診療加算再編
生活習慣病管理料

4

急性期再編

地域包括医療病棟 6 区分化
救急体制加算化

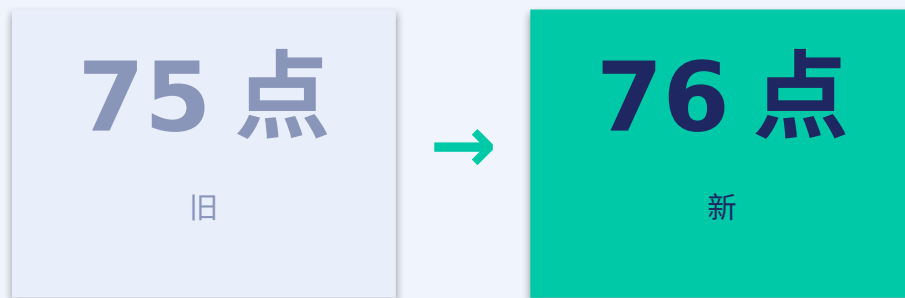
Section 1

外来改定のポイント

6つの主要変更を押さえる

- 再診料の引き上げ（75→76点）
- 機能強化加算 + BCP 義務化
- 地域包括診療加算の再編（2区分化）
- 生活習慣病管理料の変更（多科連携）
- ベースアップ評価料の拡充（6→17点）
- 物価対応料の新設

再診料・基本診療料



1 日 100 人の外来で年間約 36 万円増
初診料（288 点）・外来管理加算（52 点）は変更なし

機能強化加算と BCP 義務化

80 点（維持）

ただし施設基準に
BCP 策定が追加

2027 年 5 月 31 日

経過措置期限
未策定 = 算定不可

BCP = Business Continuity Plan（事業継続計画）
自然災害 + サイバーセキュリティの 2 本立て

地域包括診療加算の再編

認知症地域包括診療加算を統合 → 2 区分に再編

区分	点数	主な要件
加算 1	28 点	認知症対応力向上研修修了 + 従来要件
加算 2	20 点	従来の地域包括診療加算要件

管理職視点：研修修了者の確保が加算 1 の鍵
加算 1-2 の差額：8 点 / 回 → 年間約 28 万円差（100 人 / 日）

生活習慣病管理料

- 基本構造は維持（Ⅰ：610/740/780 点、Ⅱ：333 点）
- 新設：眼科連携加算・歯科連携加算
- 療養計画書の ICT 活用要件緩和

管理職視点：多職種・他科連携の体制整備が収益に直結

ベースアップ評価料

6 点

旧：医療従事者のみ



17 点

新：事務職員含む全職員

外来 100 人 / 日で年間約 600 万円増

注意：実際に賃上げに充てる必要あり（報告義務）

物価対応料（新設）

2026 年 6 月～

初診 2 点 / 再診 2 点

2027 年度～

初診 4 点 / 再診 4 点

倍増予定

小さく見えるが、積み上げると年間数十万円規模
2 段階実施：物価動向を見ながら段階的に対応

Section 2

入院改定のポイント

急性期再編の本丸

- 地域包括医療病棟の 6 区分化
- 急性期入院料の見直し
- 総合診療機能評価の新設
- 紹介患者受入加算の拡充（60 点新設）
- 救急の体制加算化

地域包括医療病棟の 6 区分化

従来の一律評価 → 6 段階の機能分化

区分	要件概要
入院料 1（最高点）	救急搬送実績 + 自宅退院率高
入院料 2	救急搬送実績あり
入院料 3	一般的な包括医療
入院料 4-6	段階的な要件緩和

管理職視点：自院がどの区分に該当するか、早期に評価が必要

急性期入院料の再編

- 看護配置・重症度基準の精緻化
- 在宅復帰率の評価強化
- 「急性期」の定義が厳格化

対応できない病院は区分変更を検討すべきタイミング

総合診療機能評価

病院における総合診療の価値が初めて点数化

- 総合診療専門医の配置が評価対象に
- 複数診療科にまたがる患者の管理を評価

管理職視点：総合診療医の採用・育成が経営戦略として浮上
かかりつけ医機能報告制度との接点も注目

紹介患者受入加算

60 点

新設

- 逆紹介の推進（大病院→診療所の流れ）
- 紹介状なし受診の抑制策と連動

管理職視点：連携パスの整備が収益に直結

救急の体制加算化

旧：院内トリアージ実施料

実施ベースの評価



新：救急医療管理加算

体制ベースへの転換
時間帯別段階評価

管理職視点：救急受入体制の整備が安定収入源に

Section 3

医療 DX 改定

「体制整備」から「実績評価」へ
体制があるだけでは不十分、使われていることが必要

旧制度→新制度の統合

廃止

医療 DX 推進体制
整備加算

廃止

医療情報取得加算



統合

電子的診療情報
連携体制整備加算

3 区分（15 / 9 / 4 点）

電子的診療情報連携の 3 区分

区分 1

15 点

電子処方箋実績
+ マイナ利用率 30% 以上

区分 2

9 点

電子処方箋
体制あり

区分 3

4 点

マイナ基本体制
のみ

区分 1 vs 区分 3 = 11 点 / 回の差
1 日 100 人で年間約 400 万円の差

マイナ保険証利用率 30% の壁

30%

区分 1 取得の必須ライン

全国平均（2026 年 3 月時点）：約 15-20%

施設でできること

- 受付でのマイナ保険証利用促進
- ポスター掲示・声かけマニュアル
- カードリーダーの動線最適化

電子処方箋の要件

電子処方箋：もはや「対応済み」が前提

- 区分 1 ・ 2 の取得には電子処方箋が必須
- 導入コスト vs 長期的な加算収入

管理職視点：未導入なら最優先で導入計画を策定

Section 4

BCP 策定義務化

もう「あると良い」ではなく「なければ算定不可」

期限：2027年5月31日

機能強化加算・在支診・在支病の施設基準

自然災害 BCP チェックリスト

7つの策定項目

- 優先業務の特定と順位付け
- 職員参集計画（連絡網・代替手段）
- 患者安全確保手順
- ライフライン途絶時の対応
- 備蓄計画（医薬品・食料・燃料）
- 地域連携体制（受入・搬送）
- 年1回以上の訓練実施

サイバーセキュリティ BCP

- バックアップ体制（3-2-1 ルール）
- ランサムウェア対策（ネットワーク分離）
- 紙カルテ運用への切り替え手順
- 全職員向けセキュリティ教育（年1回以上）
- インシデント発生時の報告・対応フロー

2024 年だけで 33 件

医療機関へのサイバー攻撃

Section 5

経営戦略

自院への影響をどう評価するか

Step 1

現在の施設基準一覧を棚卸し

Step 2

改定後の点数変動をシミュレーション

Step 3

新規取得可能な施設基準を洗い出し

Step 4

投資対効果（ROI）で優先順位づけ

施設基準 優先度マトリクス

緊急度高 × 効果大

**BCP 策定（期限あり）
ベースアップ評価料申請**

緊急度低 × 効果大

**電子処方箋導入
地域包括診療加算 1**

緊急度高 × 効果小

物価対応料の届出

緊急度低 × 効果小

その他の加算見直し

全職員への伝え方

「改定は経営の話」で終わらせない

ベースアップ評価料

「あなたの給与に直結します」

マイナ保険証利用促進

「受付での声かけが収入を変えます」

BCP

「あなたと患者を守る計画です」

事務部門・看護部門・リハビリ部門それぞれの伝え方を変える

今日から始める 5 つのアクション

今週中

施設基準の棚卸し（現状把握）

今月中

BCP 策定プロジェクトチーム発足

来月中

マイナ保険証利用率の現状把握と目標設定

6 月

改定施行 — 算定開始

2027 年 5 月

BCP 経過措置期限 — 完了必須

自院で最もインパクトが大きい改定項目はどれか？

今日の帰りの車の中で考えてみてください。